

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Cholecystectomy - Open & Exploration of the Common Bile

استئصال المرارة بالفتح الجراحي مع استكشاف قناة
الصفراء (المرّة) المشتركة

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure.
(Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:
Removal of the gall bladder through a cut at least 10 cms (4 inches) long across the right side of the abdomen, just below the rib cage.

The surgeon will also examine the tube, which carries bile from the liver to the bowel and remove any stones. A drainage tube (a T-Tube) will be inserted into the tube and brought out through the abdomen to drain bile into a drainage bag on the outside of the body. The tube will be removed in 3-6 weeks.

During surgery an examination of the bile duct is required to look for gallstones. To do this a Contrast medium is injected and x-rays are taken of the bile duct.

أ- المترجم / الاحتياج الثقافي

الحاجة لخدمات الترجمة ؟
إذا كانت الإجابة بنعم ، هل هناك مترجم حاضر ؟
☐ لا ☐ نعم ☐ لا ☐ نعم

ب . الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من :
يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق - يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي :

إزالة المرارة من خلال شق جراحي طوله 10 سنتيمتر (4 بوصات) على الأقل ، يمتد عبر الجانب الأيمن للبطن ، مباشرة أسفل القفص الصدري .

يقوم الجراح كذلك بفحص الأنبوب الناقل للمادة الصفراء من الكبد إلى الأمعاء لإزالة أي حصوات . يتم إدخال أنبوب تصريف على بالاتيني في الأنبوب المراري وإخراجه إلى (T) شكل الحرف خارج البطن لسحب وتصريف المادة الصفراء وتجميعها في كيس تصريف خارج الجسم. تتم إزالة هذا الأنبوب بعد 3-6 أسابيع خلال الجراحة ، يتطلب الأمر فحص القناة المرارية بحثاً عند حصوات المرارة . وللقيام بذلك يتم حقن مادة وسط متباين مع أخذ صور بالأشعة السينية للقناة المرارية

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

C. Risks of an open cholecystectomy and exploration of the common bile duct

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Damage to nearby blood vessels causing bleeding which could require an emergency blood transfusion and further surgery.
- Gallstones may spill from the gall bladder and be lost in the abdominal cavity. These may form abscesses, which may need drainage.
- Some stones may be left behind in the bile duct and may need further treatment.
- The T-tube may come out of position. Further surgery may be required to re-insert the T-Tube.
- Metal clips may be put on blood vessels or ducts

ج . مخاطر استئصال المرارة بالفتح الجراحي مع استئشاف قناة الصفراء (المرّة) المشتركة

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- قد يحدث التهاب ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى
- قد يحدث نزيف مما قد يتطلب إعادة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً إذا كنت ممن يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو عقار دابايير دامول (بيرسانتن أو اساسانتين)
- قد يحدث إنسداد للشعبات الهوائية الصغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بالتهاب الجرح والصدر. مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة متعلقة بهذا الإجراء:

- ضرر يصيب وعاء دموي مجاور مسبباً نزيف ، مما قد يتطلب نقل دم طارئ أو جراحة أخرى .
- قد يحدث سقوط للحصوات من المرارة وقد تبقى داخل البطن . قد يؤدي ذلك لتكوّن خراج مما قد يتطلب الإفراغ لمكوناته.
- قد تترك بعض الحصوات في القناة المرارية وقد تكون هناك حاجة لمعالجة أخرى.
- الأنبوب ذو الشكل T قد يخرج من مكانه. قد يتطلب الأمر جراحة أخرى لإعادته إلى موضعه.
- قد توضع المشابك المعدنية على الأوعية الدموية أو القنوات الصفراوية. بعض المشابك أو الأربطة قد تنفصل وتخرج من مكانها وتسبب تسرب للمادة الصفراء أو نزيف والذي قد

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

and some of the clips or ties may come off and cause a bile leak or bleeding which may become infected. This may need drainage. The metal clips will always stay in the abdomen

- Damage to the bile tubes near the liver and gall bladder which can cause short and long-term problems with leakage and/ or blockage.
- Difficulty passing urine after the operation. This may need a tube (catheter) passed into the bladder to remove the urine. This is usually temporary.
- Occasionally after the T-tube is removed, 2 or 3 weeks after the operation, bile may leak out of the bile duct to the skin or into the abdominal cavity.
- Infection in the wound causing redness, pain and possible discharge or abscess. This may need antibiotics.
- Possible bleeding into the wound with swelling and bruising and possible blood stained discharge.
- The wound may not heal normally. The wound can thicken and turn red. The scar may be painful.
- A weakness can happen in the wound with the development of a hernia (rupture). Further surgery may be needed to correct this.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause bowel obstruction. This can be a short term or a long-term complication and may need further surgery.
- Symptoms experienced before surgery may persist after the surgery
- An allergic reaction to the injected contrast is rare.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

- يتعرض للالتهاب . قد يتطلب ذلك السحب والتصريف . المشابك المعدنية تظل داخل البطن للأبد .
- حدوث ضرر للأنايب المرارية بالقرب من الكبد والحويلة المرارية مسبباً مشكلات قصيرة وطويلة الأمد من التسريب وأو الانسداد .
- صعوبة في إدرار البول بعد الجراحة ، مما قد يتطلب وضع أنبوب (قسطرة بولية) في المثانة لإخراج البول . يكون هذا عادة لفترة مؤقتة .
- في بعض الأحيان ، وبعد إزالة أنبوب (T) بعد مرور 3-6 أسابيع من الجراحة ، قد تتسرب المادة الصفراء من القناة المرارية إلى الجلد أو التجويف البطني .
- عدوى في الجرح مسببة احمرار ، ألم ، مع احتمال وجود تسريب لسوائل أو خراج . قد يتطلب ذلك مضادات حيوية .
- قد يحدث نزيف داخل الجرح مع تورم وكدمة وخروج سوائل لها لون الدم .
- قد لا يلتئم الجرح بشكل طبيعي . قد تزداد سماكته ويصبح لونه أحمر ، وقد يكون الندب مؤلماً .
- ضعف في موقع الجرح مما يؤدي إلى نشوء فتق (تمزق) . قد يتطلب إصلاح ذلك جراحة أخرى .
- قد تحدث التصاقات (أحزمة من الأنسجة المتندبة) وتسبب انسداداً للأمعاء . قد يحدث ذلك على المدى القريب أو البعيد وقد يحتاج حلاً جراحياً .
- قد لا تختفي أعراض ما قبل الجراحة بعد الخضوع للجراحة .
- من النادر حدوث رد فعل تحسسي لصبغة الأشعة السينية (متوسطة التركيز) التي يتم حقنها .

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء
(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed)

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained:

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.

هـ . مخاطر عدم القيام بالإجراء
(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . التخدير
قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

- ز . إقرار المريض
أقر بأن الطبيب قد شرح لي :
- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقعاً . أقر بأنني أتفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
 - التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أتفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
 - الخيارات الإجرائية الطبية والعلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
 - المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
 - عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.
 - قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

- ☐ **About Your Anaesthetic**
Cholecystectomy - Open & Exploration of the Common Bile Duct
- ☐ **Blood and Blood Products Transfusion**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

- احتمالية إزالة أنسجة أو دم، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:

- 0 نوعية التخدير المقدم لي
- 0 استئصال المرارة بالفتح الجراحي مع استكشاف قناة الصفراء (المرّة) المشتركة
- 0 نقل دم أو مشتقات الدم لي

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتى والتعبير عن مخاوفى فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره ، والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفى بما حقق لي الرضا.

- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعى لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.

- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني أوافق على الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض :

التوقيع :

التاريخ : الوقت:

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s: _____

Signature: _____

Relationship to patient: _____

Date: _____ Time: _____

Contact No: _____

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate: _____

Designation: _____

Signature: _____

Date: _____ Time: _____

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

المرضى فاقد القدرة على إعطاء الإقرار
يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب
ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح
أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار :

التوقيع :

صلته بالمريض :

التاريخ : الوقت:

رقم الإتصال:

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب
لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار
المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم
جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة :

التوقيع :

التاريخ: الوقت:

توقيع الشهود :

1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت : _____

2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت : _____